

TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT - NGÀ

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH
(Người bệnh có chỉ định phẫu thuật trong ngày)

Số: 03/..QTKB/TĐYTVN

Ngày ban hành: 10/10/2025

Lần ban hành: 01

Trách nhiệm	Biên soạn	Người phê duyệt
Chức vụ Họ tên	Trần Thị Thảo Nguyên	Phó tổng giám đốc BS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Ký tên		 

Lưu hành nội bộ



QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH (Người bệnh có chỉ định tiêm nội nhãn)

Mã số: 0.3.
QTKB/TĐYTVN
Ngày ban hành:
10./10/2025
Lần ban hành: 01

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của tài liệu hướng dẫn quy trình này
2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn
3. Mỗi cơ sở được phát 01 bản (có đóng dấu của người phê duyệt). Các cơ sở khi có nhu cầu thêm, đề nghị liên hệ với phòng KHTH – QLCL (Hà Nội) để có bản đóng dấu của người phê duyệt.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

☒	Ban lãnh đạo tập đoàn		
☒	Giám đốc các bệnh viện		

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

I. MỤC ĐÍCH

- Xác định trình tự, nội dung, quy trình tiếp nhận khám mắt tại Bệnh viện
- Xác định người chịu trách nhiệm thực hiện quy trình
- Thống nhất quy trình tiếp nhận và quản lý người bệnh khám và có chỉ định phẫu thuật trong ngày.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các trường hợp người bệnh khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh của Tập đoàn Y tế Việt – Nga.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện;
- Quy chế bệnh viện 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997;
- Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhân khoa;
- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;
- Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 về quy trình giám định BHYT
- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 4750/ QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của bộ trưởng bộ y tế sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

BN	: Bệnh nhân	KHTH	: Kế hoạch tổng hợp
NB	: Người bệnh	QLCL	: Quản lý chất lượng
BS	: Bác sĩ	BV	: Bệnh viện
ĐD	: Điều dưỡng	QĐ	: Quyết định
KTV	: Kỹ thuật viên	BYT	: Bộ Y tế
TKX	: Tật khúc xạ	CSKH	: Chăm sóc khách hàng
CLS	: Cận lâm sàng		

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Các bước tiếp nhận và quản lý người bệnh khám và chỉ định phẫu thuật tại bệnh viện

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 1: Đăng ký thông tin	Người bệnh /người nhà NB		Tại kiosk thông tin: - Tiếp nhận thông tin bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNeID/ CCCD hoặc có thẻ nhập trực tiếp thông tin người bệnh tại kiosk 1. Lựa chọn hình thức khám: - BHYT - Dịch vụ 2. Nhận STT <i>Đối với BN đã thực hiện đăng ký online qua app/ web bỏ qua bước này</i>	Cơ sở HCM có thêm hình thức khám theo yêu cầu (VIP)
Bước 2: Đăng ký khám bệnh	Lễ tân	Marketing/CS KH	- Tiếp nhận NB theo số TT - Khai thác sơ bộ lý do - Chọn gói khám - Chọn phòng khám / BS khám - In phiếu khám <i>(trong phiếu có hướng dẫn đến phòng khúc xạ/phòng chức năng + phòng khám và thứ tự cần thực hiện trước sau)</i> Đối với BN đăng ký online đã được Marketing tư vấn và tích gói khám -> lễ tân chỉ thực hiện in phiếu khám	CS HCM: Phát sinh STT theo đầu mã gói khám TQ – chuyên sâu – tái khám
Bước 3: Thu phí	Thu ngân		Thu phí - NB đóng phí khám bệnh theo bảng giá quy định tại Bệnh viện - Đầy công check-in (đầy tự động) – đối với NB đăng ký khám BHYT <i>NB có thể đóng phí bằng QR code động -> đưa bill giao dịch thành công cho thu ngân -> thu ngân xác nhận đã thanh toán -> BP. lễ tân đưa hồ sơ khám cho NB</i>	- CS HCM: Thu chênh đối với toàn bộ NB đăng ký khám BHYT ở các bước có thu phí - CS HL, HP: Thu toàn bộ chi phí, kết thúc khám sẽ hoàn lại tiền cho bệnh nhân
Bước 4: Đo thị lực, khúc xạ và	KTV Khúc xạ/ điều dưỡng Phòng khúc xạ/ chức		NB cầm phiếu khám <i>(trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khúc xạ/ phòng chức năng)</i> , thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng, thực hiện đo	* CS HN, HL, HP: -Thực hiện thêm chỉnh kính - Đo nhãn áp hơi (đối với NB $\geq$ 40 tuổi)

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
nhấn áp	năng		1. Đo khúc xạ tự động 2. Đo thị lực: - Không kính - Kính lỗ - Kính cũ (nếu có) 3. Đo nhãn áp hơi (trừ trường hợp NB bị viêm nhiễm và trẻ em dưới 15 tuổi) 4. Nhập toàn bộ kết quả lên phần mềm và in kết quả Hướng dẫn NB đến phòng có ghi trên phiếu khám	
Bước 5 Khám	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng phòng khám	NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khám</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, chờ đến lượt vào phòng Khi đến lượt, bệnh nhân sẽ được mời vào gặp bác sĩ khám: 1. Khám -> phát hiện bệnh lý khác (<i>không cùng bệnh lý đk khám ban đầu</i>) -> chuyển quy trình khám ngoại trú (kê đơn) 2. Khám -> Đúng bệnh lý theo gói đk ban đầu -> chỉ định CLS chuyên sâu theo gói đã đăng ký -> in chỉ định -> hướng dẫn NB thu phí (nếu có)	
Bước 6 Thực hiện CLS theo gói khám đã đăng ký + Khúc xạ khách quan	- Điều dưỡng Phòng CDHA/ Khúc xạ/ Chức năng quan		NB cầm phiếu chỉ định (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng cần đến</i>) -> checkin (<i>tại phòng có trong phiếu hướng dẫn</i>) -> nhận STT -> chờ đến lượt -> thực hiện chỉ định CLS theo gói đã đăng ký -> điều dưỡng/KTV Đẩy hình ảnh lên Forum hoặc Pacs => NB quay trở lại phòng khám ban đầu (<i>vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng</i>)	
Bước 7 Khám lần 2 và Đọc kết quả CLS	Bác sĩ/ phiên dịch tại phòng khám	Điều dưỡng phòng khám	NB cầm phiếu khám (<i>trong đó có hướng dẫn đi đến phòng khám</i>), thực hiện check-in, nhận STT, chờ trước cửa phòng, theo dõi STT hiển thị trước màn hình, đến lượt vào phòng	CS HCM: Chính kính (BS Nga tự chỉnh kính) – nếu có, BS Nga tự nhập KQ vào phần mềm

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			- NB chờ đến lượt vào phòng khám theo sự điều phối của điều dưỡng - Khi đến lượt, bệnh nhân sẽ được mời vào gặp bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ thực hiện khám chi tiết: - Hỏi bệnh - Khám sinh hiển vi - Soi đáy mắt - BS người Việt sẽ đọc và trả kết quả trên forum và Pacs, ký số trả kết quả - BS người Nga đọc đọc và trả kết quả trên form và pacs, phiên dịch hỗ trợ dịch trên phiếu trả kết quả. BS và phiên dịch cùng ký trên phiếu trả kết quả CDHA. Phiên dịch ký trước bằng chữ ký điện tử, BS ký sau và ký số. - Tư vấn, GDSK, ghi nhận thông tin về tình trạng người bệnh trên phần mềm về tình trạng bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, chỉ định điều trị - ĐD hỗ trợ BS giải đáp những thắc mắc liên quan đến KCB, hướng dẫn sử dụng thuốc và chăm sóc mắt... cho NB trong phạm vi chuyên môn cho phép	trên form riêng của BS
Bước 8 Hướng xử trí	Bác sĩ chuyên khoa	Điều dưỡng phòng khám	1. Các hướng xử trí: - Chỉ định thêm CLS: Thực hiện tương tự như bước 6 - Chỉ định thủ thuật (tiểu phẫu): + In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> NB nộp phí KHÔNG THU PHÍ: chỉ định chỉnh kính/những cận lâm sàng thực hiện lặp lại theo yêu cầu của bác sĩ : in phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn phòng cần đến) -> thu phí (giảm trừ 100%) -> checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng)-> thực hiện-> phòng khám ban	

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
			đầu (vào phòng ưu tiên theo sự điều phối của điều dưỡng) - NB có chỉ định phẫu thuật => chuyển phòng Marketing/CSKH	
Bước 9 Thực hiện thủ thuật (nếu có)	Điều dưỡng		1. NB Checkin (tại phòng có trong phiếu hướng dẫn) -> nhận STT -> chờ đến lượt 2. Mời người bệnh vào thực hiện theo STT 3. ĐD. Giải thích hướng dẫn người bệnh phối hợp - Thực hiện theo chỉ định - Trả kết quả trên PM - Hướng dẫn BN quay trở lại phòng khám	
Bước 10 Tư vấn	Marketing/CSKH	Thu ngân	- Tư vấn chi phí gói phẫu thuật - Hướng dẫn NB đặt cọc đối với trường hợp NB không phẫu thuật trong ngày=> NB quay trở lại PK nhận đơn thuốc - Hướng dẫn NB quay về phòng khám ban đầu, nhận phiếu chỉ định nhập viện	
Bước 11 Hướng xử trí	Bác sĩ	Điều dưỡng phòng khám, khoa dược, khoa xét nghiệm	1. Kê đơn: BS kê đơn điều trị các bệnh lý khác phát hiện trong quá trình thăm khám -> hẹn lịch phẫu thuật 2. Đặt kính/ IOL với nhà cung cấp: đối với những trường hợp chưa có sẵn IOL, kính... 3. Chỉ định xét nghiệm -> NB nộp phí xét nghiệm-> khoa xét nghiệm lấy mẫu và trả kết quả 4. Chỉ định nhập viện Điều dưỡng thực hoàn tất hồ sơ, thủ tục trước khi nhập viện bàn giao cho ĐD khoa tiến hành điều trị nội trú Phiếu bàn giao người bệnh (điều dưỡng) Phiếu khám bệnh vào viện Các phiếu kết quả	CS HCM xét nghiệm làm trong nội trú CS HN, HL, HP: Các xét nghiệm làm ngoại trú, khi có kết quả mới nhập viện điều trị nội trú * Đối với các CS không thực hiện KCB BHYT ngoại trú: - CS HN: ĐD chuyển đối tượng BHYT trước khi chỉ định xét nghiệm và chỉ định nhập viện CS HCM: Đối đối

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
				trợ từ dịch vụ - BHYT (nếu có) – Lễ tân thực hiện - Khoa điều trị nội trú khi tiếp nhận NB đầy check – in công BHYT
Bước 12 Nhập viện	Điều dưỡng khoa tiến hành điều trị nội trú		Tiếp nhận bệnh nhân - Xác nhận bàn giao giữa 2 khoa - Thực hiện kê giường	
Bước 13 Chi định CLS	BS khoa tiến hành điều trị nội trú	Điều dưỡng	* CS HCM - Khám, chỉ định thuốc trước phẫu thuật - Chỉ định Xét nghiệm (theo từng gói) + Khám nội + Đo điện tim * CS HN, HL, HP: - Khám, chỉ định khám nội, đo điện tim - Chỉ định thuốc trước phẫu thuật - Lập phiếu chăm sóc In phiếu chỉ định (trong phiếu có hướng dẫn số phòng và thực hiện thứ tự từng dịch vụ) Hướng dẫn NB đóng phí (nếu có)	
Bước 14 Thu phí			Thu phí xét nghiệm Thu tạm ứng (số tiền thu tạm ứng = số tiền thực kê)	CS HN, HL, HP bỏ qua bước này
Bước 15 Thực hiện xét nghiệm	KTV xét nghiệm		NB cầm phiếu chỉ định xét nghiệm (có hướng dẫn đến phòng XN) -> Check in -> nhận STT -> Thực hiện xét nghiệm -> Nhập kết quả xét nghiệm vào phần mềm HIS. Kết quả XN sẽ tự trả về phòng BS khám nội Hướng dẫn NB chờ trước phòng khám nội	CS HN, HL, HP bỏ qua bước này
Bước 16 khám nội + đo điện tim	BS nội / BS GMHS	Điều dưỡng	NB được mời vào phòng thực hiện - Khám nội - Đo điện tim Nhập kết quả vào phần mềm	
Bước 17	Lãnh đạo bệnh viện	PTV và BS điều	- Trường hợp Không đủ điều kiện phẫu thuật -> cho NB ra về điều trị chuyên khoa	

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Hội chẩn		trị, BS GMHS	(nếu cần) -> Kết thúc hồ sơ - Trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật -> chỉ định phẫu thuật + Mắt phẫu thuật + Phương pháp phẫu thuật + Vật tư y tế, thuốc phát sinh ngoài gói (nếu có) + Công nghệ kèm theo (nếu có) + Tích chỉ định gói PT + những phát sinh ngoài gói. Hướng dẫn bệnh nhân đóng phí	
Bước 18 Thu phí	Thu ngân	Kế toán BHYT/ CSKH	- Thu phí gói phẫu thuật + những phát sinh ngoài gói + thuốc Thu tạm ứng (số tiền thu tạm ứng = số tiền thực kê) - Hướng dẫn NB / thân nhân người bệnh về phòng chờ	
Bước 19 Chuẩn bị trước phẫu thuật	Điều dưỡng khoa tiến hành điều trị nội trú	Hộ lý	- Thực hiện y lệnh thuốc - Điều dưỡng đối chiếu tên trên phiếu thu với các chỉ định, in vòng đeo tay - Điều dưỡng / Hộ lý hướng dẫn bệnh nhân thay quần áo và chờ tại phòng đợi đến lượt phẫu thuật - Đến lượt, Điều dưỡng / Hộ lý hướng dẫn bệnh nhân đến khu vực phòng mổ	
Bước 20 Phẫu thuật	Bác sĩ		Tiến hành Phẫu thuật theo quy trình BHYT	
Bước 21 Khám lại trước khi ra viện	Bác sĩ	Điều dưỡng	1. Khám lại và hẹn tái khám 2. Kê đơn thuốc ra viện 3. Nhận thuốc – Điều dưỡng hướng dẫn cách chăm sóc và hướng dẫn sử dụng thuốc tại nhà 4. NB ký bảng kê chi phí điều trị nội trú 5. NB nhận giấy ra viện	CS HN, HL, HP: Khoa Mắt hướng dẫn NB ký bảng kê chi phí BHYT

Trình tự	Người thực hiện	Người phối hợp	Chi tiết công việc	Ghi chú
Bước 22 Thanh toán ra viện	Thu ngân Kế toán BHYT		1. Đối với NB không sử dụng BHYT NB được Điều dưỡng / Hộ lý hướng dẫn ra về, bàn giao NB cho thân nhân 2. Đối với NB có sử dụng BHYT: - NB được Điều dưỡng / Hộ lý hướng dẫn ra về, bàn giao NB cho thân nhân và hướng dẫn đến khu vực kế toán BHYT (L3), ký bảng kê chi phí BHYT - Nhận lại CCCD/ thẻ BHYT (nếu có) - Thu ngân thực hiện quy trình đòi biên lai tạm ứng – biên lai thu phí	CS HCM: Hướng dẫn đến khu vực kế toán ký bảng kê chi tiết dịch vụ đã thực hiện Cơ sở HN, HL, HP: Hoàn lại tiền BHYT thanh toán cho người bệnh
Bước 23 Kết thúc tiêm			KẾT THÚC QUY TRÌNH – LƯU HỒ SƠ Khoa tiến hành điều trị nội trú kết thúc HSBS nội trú	

Lưu ý:

1. Phát sinh mã QR động, NB có thể nộp phí ở bất kỳ đâu không cần đến quầy thu ngân
2. Khi xác nhận đã thu phí, tên NB mới thể hiện tại phòng có chỉ định để thực hiện trả kết quả

